

מתן אופיאטים כטיפול בקוצר נשימה בחולה הנוטה למות

מבוא

הנושא של מתן טיפול במורפין בסוף החיים נדון רבות בספרות הרפואית וההלכתית. במאמר זה ברצוננו לדון במקרה ספציפי - מתן מורפין עבור חולים עם קשיי נשימה (Dyspnea). בדרך כלל כאשר דנים בנושא זה מזווית הלכתית ואתית עולה השאלה של קיצור חיים לעומת מניעת סבל. במקרה מיוחד זה של קוצר נשימה ישנם מצבים בהם מתן מורפין יכול למנוע את הסבל ללא קיצור חיים, ואף להאריך חיים בעצמו. סקירה רפואית והלכתית בנושא זה יכולה להשפיע על ההכרעות ההלכתיות ועל פסקי ההלכה הניתנים בשאלות של סוף החיים.

דיספניאה (Dyspnea)

דיספניאה, או קוצר נשימה, מוגדר כ"חויה סובייקטיבית של אי נוחות בנשימה" שנוכחותה במצבי סוף החיים היא מנבא חזק של תמותה(1). קוצר נשימה נפוץ במצבי מחלה קשים ומתקדמים: סרטן מתקדם, אי ספיקת לב ומחלות ריאה כרוניות. שלוש מחלות אלו יחד אחראיות ליותר מ-50% ממקרי המוות בארצות הברית. בחולי סרטן השכיחות של קוצר נשימה היא 50% עד 70%, עם שכיחות של עד 90% בחולים עם סרטן ריאות. כמו כן, 90% מהחולים עם מחלת ריאות חמורה ו-50% מחולי אי ספיקת לב, חווים קוצר נשימה משמעותי(2).

בשלוש קבוצות המחלות לעיל (סרטן מתקדם, אי ספיקת לב ומחלות ריאה כרוניות), קוצר נשימה הינו בעיה תדירה, חמורה ומעיקה(2), בעיקר בששת החודשים האחרונים לחיים. יתרה מזו, במהלך שלושת הימים האחרונים לחייהם, קוצר נשימה קיים בשלב מסוים ב-90% מהחולים(2).

מטופלים הקרובים למוות לעיתים קרובות אינם מסוגלים לדווח בעצמם על תחושה מעיקה ביותר של קוצר נשימה. כתוצאה מכך, פעמים רבות המטופלים אינם מקבלים טיפול מתאים העשוי להקל על תסמין זה(2).

טיפול במורפין

אחד האמצעים לטיפול בקוצר נשימה הוא השימוש בתרופות מקבוצת האופיאטים, כאשר מורפין הינו סוג אחד של אופיאט אשר הוכח במחקרים כמטפל ביעילות בקוצר הנשימה.

איגודים רפואיים בינלאומיים מובילים ממליצים על שימוש באופיאטים עבור קוצר נשימה, ובהם: האגודה האמריקנית לאונקולוגיה קלינית, American College of Chest Physicians (ACCP), American College of Physicians (ACP), American Thoracic Society (ATS), Canadian Thoracic Society, National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Cancer Care Ontario ועוד. האיגודים הללו ממליצים על שימוש במורפין במתן תוך ורידי עם זהירות מתאימה בשל הסיכון לדיכוי נשימתי(1).

ביחס למינון מורפין הניתן לחולים עם קוצר נשימה כטיפול פליאטיבי הומלץ על מתן של 2.5 מ"ג תוך ורידי. אם קוצר הנשימה ממשיך, הומלץ לתת מנה זו כל 15-30 דקות. אם עדיין המטופל חווה קוצר נשימה ניתן להכפיל את הכמות הניתנת¹(3).

מנגנון ההשפעה של אופיאטים על דיספניאה אינו מובן במלואו, אך הוא קשור ככל הנראה להרגעת תחושת אי-הנוחות הנשימתית ברמת מערכת העצבים המרכזית. אופיאטים מפחיתים את הרגישות למצוקה נשימתית ואת תחושת ה"רעב לאוויר", ובכך מקלים על החולה מבלי בהכרח לשפר את פרמטרי הנשימה האובייקטיביים. חשוב להדגיש כי הדיון במאמר זה מתמקד ספציפית בשימוש באופיאטים לטיפול בדיספניאה במינונים ובמצבים המתוארים.

אך, למרות יעילותו בהקלה על קוצר נשימה ומצוקה נשימתית, השימוש במורפין עדיין אינו נפוץ במחלקות בתי החולים עבור מטופלים הנוטים למות. כך למשל נמצא במחקר רטרוספקטיבי אשר נערך בברזיל בשנת 2018. במחקר זה בחנו את הטיפול שניתן ל-296 מטופלים בסוף חייהם (86% מהם חולי סרטן) אשר טופלו באופן פליאטיבי. 230 (77%) מהמטופלים הללו סבלו מדיספניאה. שימוש במורפין תועד ב-168 חולים (73% מתוך המטופלים שסבלו מדיספניאה) והיה מצוי הרבה יותר בבית חולים אונקולוגי מאשר בבית החולים הכללי (84.5% לעומת 15.5%)(4).

יש לציין שתי מגבלות לנתונים אלה: ראשית, רוב המטופלים שנכללו במחקר הם חולי סרטן, ולכן הנתונים על שכיחות השימוש במורפין בקרב חולים פליאטיביים שאינם אונקולוגיים (כגון חולי מחלת ריאות כרונית [COPD] סופניים, אי-ספיקת לב, ופיברוזיס ריאתי) מוגבלים. שנית, בעוד שממצאי המחקר נותרו רלוונטיים גם בחלוף השנים וגם סקירות שיטתיות(2,14) עדכניות מאשרות כי תת-השימוש באופיואידים לדיספניאה בסוף החיים הוא תופעה עקבית ומתמשכת, הנובעת משילוב של אי-זיהוי הסימפטום, חוסר בהנחיות ברורות, וחשש מהאצת

¹ הערת ד"ר משה גרינברגר, רופא בתחום רפואה פליאטיבית: המינון בפועל הינו אינדיבידואלי, תלוי מטופל ומצב. למשל, מטופל שכבר מקבל מינונים גבוהים של אופיאטים מסיבות אחרות (כגון כאב אונקולוגי), כמובן לא יגיב לתוספת מינון כה נמוכה להקלה על קוצר נשימה. כך שהכל לפי העניין, ולפי שיקול דעת של הרופא המטפל.

תהליך המוות, נתונים ספציפיים על מצב הטיפול בדיספניאה פליאטיבית בישראל אינם זמינים בספרות המפורסמת - פער שיש לו השלכות מחקריות ומעשיות כאחד.

בהקשר זה ראוי לדון בשלושה פרסומים עדכניים שעוסקים בשאלה זו. המטא-אנליזה של סמולווד, פסקו, ויז'נבק ועמיתיהם (Smallwood et al., Eur Respir Rev) (2024;33:230265) סקרה את מכלול הניסויים האקראיים על אופיאטים בחולים במחלות נשימה חמורות, ומצאה כי אופיאטים שיפרו קוצר נשימה בזמן מאמץ בתנאי מעבדה, אך לא הדגימו שיפור מובהק בתסמינים בחיי היום-יום, לצד תופעות לוואי משמעותיות. על בסיס מטא-אנליזה זו פרסמה החברה האירופאית לנשימה הנחיות קליניות חדשות (Holland et al., Eur Respir J 2024;63:2400335), שהמליצו בזירות שלא להשתמש באופיאטים - המלצה מותנית, בשל ודאות ראיות נמוכה מאוד. פסקו וסמולווד (Expert Rev Respir Med) (2025;19:83-85) הוסיפו לאחרונה כי קוצר נשימה כרוני נותר תסמין מעיק עם מיעוט אפשרויות טיפוליות בטוחות ויעילות. אולם חשוב להדגיש: ההנחיות האירופאיות עצמן ציינו במפורש כי אף אחד מהמחקרים שנכללו במטא-אנליזה לא כלל חולים בשלב סוף החיים ממש. לפיכך, מסקנותיהם אינן מתייחסות לאוכלוסייה שהיא מוקד המאמר הנוכחי - חולים הנוטים למות עם דיספניאה עקשנית - ואינן עומדות בסתירה לראיות המובאות להלן בנוגע לאוכלוסייה זו.

כעת, לאחר הקדמה זו, נעבור לעסוק באופן פרטני בשלוש המחלות שהוזכרו לעיל, בהן ניתן לטפל במורפין למטופלים עם קוצר נשימה, ונסקור את הספרות הרפואית בשאלה האם מתן מורפין אכן יכול לשפר את קשיי הנשימה ללא סיכון לקירוב המוות או פגיעה בבריאות המטופל.

סרטן וקוצר נשימה

קוצר נשימה הוא אחד התסמינים השכיחים ביותר בחולי סרטן, במיוחד אלו עם סרטן ריאות. בין 54% ל- 84% מחולי סרטן ריאות חווים צורה כלשהי של קוצר נשימה, אשר מוחמר במיוחד בשלבים הסופיים של המחלה (5,6).

אחד המחקרים בדק קבוצה של 124 מטופלים חולי סרטן עם קוצר נשימה, כדי לבדוק את שיפור תחושת קוצר הנשימה לאחר מתן אופיאטים. המחקר אכן מצא כי קוצר נשימה השתפר באופן משמעותי 24 שעות לאחר התחלת מתן אופיאטים (7). לפיכך תומך המחקר בהמלצה כי אופיאטים נחשבים לבחירה הראשונה של טיפול תרופתי לקוצר נשימה במטופלים עם סרטן ריאה (7).

מחקר נוסף חשוב אשר נערך לפני מספר שנים בבית החולים הדסה הר הצופים, בדק את ההשפעה של אופיאטים על חולי סרטן, ובדק בנוסף את ההישרדות לאחר מתן אופיאטים (8). נמצא, מתוך סקירה של 114 מטופלים, כי הגדלת מינון האופיאטים הייתה קשורה לשיפור ההישרדות בהשוואה למינון ללא שינוי או ירידה במינון הכולל. בקבוצה אשר היתה בה הגדלה של מינון אופיאטים נצפתה הישרדות ממוצעת של 14 ימים לעומת 9.3 ימים בקבוצה ללא שינוי במינון הקבוע, ולעומת 9.1 ימים בקבוצה בה הייתה ירידה במינון הכולל. כל התוצאות היו מובהקות סטטיסטית.

יש לציין כי מחקר זה בדק בעיקר את הקשר בין שינויי מינון אופיאטים לבין הישרדות בחולי סרטן, ולא השווה ישירות בין חולים שטופלו באופיאטים לאלה שלא טופלו כלל באופיאטים. רוב החולים היו חולי סרטן, ולכן יש מגבלה בהכללת הממצאים לחולים עם דיספניאה ממחלות אחרות.

מחקר דומה נעשה גם בטיוואן על 136 מטופלים עם סרטן וקוצר נשימה, וגם שם נמצא כי מורפין לא הוריד שרידות, בין אם ניתן בתחילת האשפוז ובין אם ניתן במהלך 48 שעות לאחר קבלתו של המטופל לבית החולים עם הסתמנות של דיספניאה וסרטן (9).

אי ספיקת לב (Heart failure) וקוצר נשימה

אי ספיקת לב היא מחלה שכיחה, ושכיחותה עולה עם הגיל, עד כדי 20% מהאשפוזים בבתי חולים במטופלים מעל גיל 65 (10). שכיח מאוד לפגוש בחדר המיון מטופלים אשר סובלים מקוצר נשימה כתוצאה מאי ספיקה לבבית. קוצר הנשימה נגרם כתוצאה מהצטברות של נוזלים בריאה מחוסר כיווץ לבבי מספק, כך שהדם אינו מצליח לזרום לשאר חלקי הגוף בצורה מתאימה ומצטבר בריאות, המתמלאות בנוזל, מצב המקשה על הנשימה. הגורם לכך יכול להיות פגיעה ראשונית בתפקוד הלב עצמו, או משנית למחלה אחרת ("טריגר") שגרמה לירידה יחסית בתפקוד הלב, למשל במצב של זיהום חריף או אירוע לבבי.

נהוג לחלק את רמת אי הספיקה הלבבית לארבע דרגות, כאשר הדרגה הרביעית הינה ההתייצגות החמורה ביותר, בה מופיע קוצר נשימה אף בזמן מנוחה או פעילות קלה.

אחד המאמרים (11) אשר בחן מתן מורפין במקרים כאלה הראה שיפור מאוד משמעותי בתחושת קוצר הנשימה ואף הסטורציה (ריווי החמצן בדם), במטופלים עם אי ספיקה לבבית משמעותית. במחקר זה לקחו 43 מטופלים בין השנים 2013-2018 אשר היו עמידים בפני טיפול

אחר לבצקות ריאות (refractory heart failure) ונתנו להם מורפין במינון של 5 מ"ג ליום (מינון נמוך). כל המטופלים הללו הראו שיפור בקוצר הנשימה ובקצב הנשימה 24 שעות לאחר ההתחלה של מתן מורפין. לא נצפתה בעקבות הטיפול ירידה משמעותית בריווי החמצן בדם, לחץ הדם וקצב הלב. תופעות הלוואי השכיחות היו דליריום (18%) ועצירות (8%); לא התרחשה תופעת לוואי קטלנית הקשורה לטיפול במורפין במהלך הטיפול. החוקרים ממליצים על הפרקטיקה הקלינית של טיפול במורפין והציעו שטיפול במורפין עשוי להיות אפשרי עבור קוצר נשימה עקשן, במסגרת טיפול פליאטיבי בחולים עם אי ספיקה לבבית מתקדמת.

COPD ומורפין

מחלה נוספת שמאוד נפוצה, הינה מחלת COPD (chronic obstructive pulmonary disease), מחלת ריאה כרונית אשר נגרמת בעיקר כתוצאה מחשיפה ממושכת לעישון. חלק משמעותי מפניות של חולים לחדר מיון בשל קוצר נשימה הוא בשל החמרה במחלה זו. המחלה שכיחה אצל מטופלים אשר נחשפו לעישון במשך שנים רבות, ויכולה להופיע ברמות חומרה שונות, ממחלה קלה ועד מחלה קשה הכרוכה בסכנת חיים ודורשת טיפול קבוע.

לצערנו, מלבד אינהלציות וסטרואידים אין טיפול טוב להקלה על קוצר הנשימה במחלה זו, ובמצבים מתקדמים גם תרופות אלו אינן יעילות. לכן, בשנים האחרונות נערכו מחקרים שבהם בדקו את אפשרות הטיפול במורפין במטופלים עם COPD קשה. חלק ממטופלים אלו נמצאים בשלב סופני, בין אם בשל המחלה עצמה, ובין אם בעקבות מחלה אחרת אשר מחמירה את ה-COPD. במחקר משנת 2020 עקבו אחר 111 מטופלים אשר קיבלו מורפין במינון 10 מ"ג ביום המשתחרר בצורה איטית, וטופלו כך במשך 4 שבועות. נמצא כי מתן מורפין שיפר את המצב הבריאותי בחולים עם COPD מבלי להשפיע על ריכוז פחמן דו חמצני בדם ומבלי לגרום לתופעות לוואי חמורות. לא אירעו אשפוזים או מקרי מוות הקשורים למורפין (12). על בסיס מחקר זה הומלץ לתת למטופלים קשים וסופניים עם COPD טיפול במורפין, כדי להקל על קשיי הנשימה ועל יכולות התפקוד של המטופל.

מתן מורפין בחדר מיון

למרות שימוש נרחב בשירותי ההוספיס (מרכז לטיפול תומך), וההעדפות המוצהרות של רוב החולים הסופניים למות בבית, חולים רבים מגיעים לחדר המיון בסוף חייהם. כך נוצר מצב בו

רופאי חדר המיון נאלצים להתמודד יותר ויותר עם מצבי סוף החיים. מחקר שנעשה בארה"ב על קבוצה של מבוגרים בני 65 ומעלה שנפטרו (ולא על חולי סרטן בלבד) הראה ש-51% מהם ביקרו בחדר המיון בחודש האחרון לחייהם - כשליש מהם חולי סרטן, וכמחצית חולי לב וריאות. באותו מחקר נמצא כי מטופלים שהוקצו למסגרת הוספיס חודש לפני מותם, כמעט ולא הגיעו לחדר המיון בתקופה זו - ממצא המחזק את חשיבות ההפניה המוקדמת לטיפול פליאטיבי (13).

חלק גדול מהמחקרים אשר הצגנו עד כה עסקו במתן מורפין באשפוז או בהוספיס. אך נראה כי עבור חולה הנוטה למות יש חשיבות משמעותית להתחיל טיפול במורפין כבר בהתייצגותו בחדר מיון עם קוצר נשימה (14).

אחד המחקרים שבחן התחלת טיפול במורפין בחדר מיון, עסק בשיטה שבה אחיות נתנו מורפין למטופלים עם **כאב** כבר עם הגעתם, אף לפני הערכת רופא (15). מתוך 349 המטופלים שהתייצגו בחדר המיון, רק בחמישה מקרים הייתה ירידה בסטורציה – כולם טופלו בחמצן ומצבם השתפר. מסקנת המחקר הייתה שאחיות מנוסות יכולות ליזום טיפול במורפין בבטחה, לפני הערכת הרופא. אמנם מחקר זה עסק בכאב ולא התייחס ספציפית למקרים של קוצר נשימה, אך ממצאיו בנוגע לפרופיל הבטיחות של מורפין בחדר מיון – שבו קיימים כלים לטיפול בסיבוכים אפשריים – רלוונטיים גם להקשר פליאטיבי. יש לציין כי מדובר בטיפול ראשוני ולא מתמשך; תפקידו של חדר המיון הוא להעניק הקלה מיידית ולהוות נקודת כניסה להמשך טיפול פליאטיבי, בין אם בהוספיס ובין אם בקהילה.

דיון הלכתי

ברוב הדיון ההלכתי המצוי בפוסקי הדור האחרון, ובראשם שו"ת מנחת שלמה (ח"ב סי' פב אות א), שו"ת ציץ אליעזר (חי"ג סי' פז; חי"ד סי' קג), ושיעורי תורה לרופאים (ח"ג סי' קצט), נדונה בדרך כלל שאלת מתן מורפין למטופל כשאלה של קיצור חיים כדי למנוע סבל וכאב². כך למשל באחת השאלות ששאל פרופ' שמעון גליק את הרב שלמה זלמן אויערבאך אשר התפרסמה באסיא (כרך יא):

"איך לנהוג בחולה שסובל ממחלה קשה שכנראה הגיע ל'סוף הדרך' עם סרטן או מחלות אחרות שלפי כל הערכה רפואית לא ניתן עוד לטיפול משמעותי והוא סובל מכאבים קשים. יש אפשרות לתת לו זריקות מחומרים שמרגיעים את הכאבים ומורידים

² דיון בנושא בהרחבה עם הנחת מוצא זו ניתן למצוא גם בנייר העמדה המפורט של 'צוהר' אשר מופיע באתר צוהר (נכתב על ידי הרב שרלו, הרב גנזל, והרב ברוכי). **אולם** נייר מידע זה בעיקר התמקד במניעת כאב אשר עלול לקצר חיי אדם ולא ספציפית בקוצר נשימה.

את הסבל, אבל כמעט כל אותם תרופות ג"כ קצת מרדימות וכמעט בטוח שהם ממהרים את עיתוי המוות הסופי של החולה".

בהתאם להנחת השאלה, אשר הייתה אכן ההנחה הרפואית באותה תקופה, נענתה תשובה בהתאם:

הואיל וייסורים קשים מאוד לאדם ואי אפשר לסובלם, וכמאמרם אלמלי נגדוה לחנניה וכו', מסתבר שצריכים לרחם על החולה ולהקל עליו את סבלו ולהשקיע במעט את הכאבים, ובפרט דגם אפשר שכאבים חזקים מחלישים ומזיקים לאדם יותר מהתרופות. אך אם החולה הוא בהכרח חושבני שצריכים להודיע לו על כך אם הוא בלאו הכי יודע את מצבו. אך אפילו אינו יודע, מכל מקום מצינן בגמ' סנהדרין (פד ע"ב) ועיי"ש ברש"י שכתב **ואהבת לרעך כמוך, לא הוזהרו ישראל מלעשות לחבריהם אלא דבר שאינו חפץ לעשות לעצמו עכ"ל**. ובנדון זה שלפנינו הרי כל חולה מבקש ומתחנן להשקיע הכאבים ואע"פ שזה מזיק. וכיון שכן מסתמא אנן סהדי דניחא לו.

כמובן דכל זה דווקא אלא באופן שהכוונה היא אך ורך להשקטת הכאבים, ומה שזה עלול לקרב קיצו הוא כעין פסיק רישא דלא ניחא לו (כוונתי בהזכרת העניין של פס"ר היא רק על דרך המליצה). גם מצינן בש"ס בכמה מקומות על הרבה דברים שהם ממש קרוב לסכנה ואפילו הכי כיון דנהוג עלמא לעשות כן אמרינן "והאידנא שומר פתאים ה'" וכיון שדרך כל החולים הוא בכך יתכן דשייך שפיר לומר דבר זה גם בנד"ד וצריכים שפיר להשקיע הכאבים וה' ירחם".

כלומר, הרב אויערבאך מסביר שאף שייתכן שמתן מורפין מקצר את החיים, הרי שניתן לעשות זאת מכיוון שזה נחשב כעין פסיק רישא דלא ניחא לו, וגם משום שניתן לומר במקרים הללו את הכלל 'שומר פתאים ה'". לכן אף שיש סיכון לגרימת מוות מוקדם, הדבר מותר לצורך מניעת סבל וקיום מצוות 'ואהבת לרעך כמוך'.

דרך אחרת להתמודד עם בעיית קיצור החיים, היא תשובתו של הרב יצחק זילברשטיין בנושא, שפורסמה אף היא בכתב העת אסיא (נט-ס עמ' 52-57). כדי להתיר מתן מורפין במצבים אלו בהם ההנחה היא כי ייתכן קיצור חיים עקב הטיפול, נעזר הרב זילברשטיין בצירוף שלש סברות:

1. **לימוד משאול המלך** - הרב זילברשטיין מביא מספר פירושים העוסקים במקרה של שאול המלך, בו שאול אומר לנושא כליו "שלוף חרבך ודקרני בה, פן יבאו

הערלים האלה ודקרוני, והתעללו בו...ויקח שאול את החרב ויפול עליה" (שמואל א, לא, ד). לפי אחד הפירושים נלמד מכאן שמותר לאדם למסור עצמו למיתה כדי להינצל מיסורים קשים כפי שעשה שאול:

"ונראה דבענינו **אולי יש מקום להתיר נתינת מורפין כדי להשכיך את**

הכאבים הנוראים והוא משום דלשיטה א', מותר לאדם למסור עצמו למיתה כדי להנצל מייסורים קשים של התעללות, ואולי הרגשת חנק דומה לזה. ואמנם שאר השיטות כולם חולקים על השיטה הזו ואוסרים וכך הכריע גם 'בדק הבית'.

2. **חלוקה בין מורפין המרגיע לבין תרופה הממיתה - הרב זילברשטיין**

מעלה סברא נוספת להיתר על פי ניתוח אופן פעולתו של המורפין:

"אולם ייתכן שמורפין לכל הדעות מותר לתת. והוא משום דהמורפין ביסודו

הוא תרופת הרגעה ואינו ממית את החולה, מצד עצמו, אלא גורם לו להירגע וממילא אינו נלחם בכל תוקף לנשום כדי לחיות, וחולה בעל סבל רב כזה אינו חייב לעשות מאמצים לנשום כדי לחיות. וכשם שאין חיוב לתת תרופות להאריך חיי סבל הקשים מנשוא, כמבואר ב"אגרות משה" (ח"מ ח"ב סימן עג) שכתב: 'וחולה כזה שהרופאים מכירים שאי אפשר לו להתרפאות ולחיות, ואף לא שיחיה כמו שהוא חולה בלא יסורים, אבל אפשר ליתן לו סמי רפואה להאריך ימיו כמו שהוא נמצא עתה ביסורים, אין ליתן לו מיני רפואות אלא יניחוהו כמו שהוא'."

3. **מותר להקל ייסורים - הרב זילברשטיין מצטט את מכתבו של הרב יעקב**

ישראל קניבסקי זצ"ל (נדפס בספר "קריינא דאיגרתא"): "כך אין החולה חייב לסבול חיי חנק כדי להוסיף מאמצים בנשימתו הנואשת. ומותר לו להיות מטושטש קצת בהכרתו ולנוח קמעה מייסוריו הנוראים ולכן ייתכן שלכל השיטות הנ"ל מותר לתנו לחולה מאחר ואין זה פעולת המתת "חסד" כי אם מעשה של הקלת ייסורים."

בניגוד לדעות אלו, כתב הרב אביגדר נבנצאל (אסיא, חוברת כה-כו, שנת תש"מ) לאסור

מתן מורפין בשל החשש לקיצור החיים:

"ולפי זה, בתרופות הנזכרות **המקצרות משך חייו של החולה, שכבר סיבת המוות**

מקננת בגופו, לכאורה אין בגדר גרם רציחה אלא בגדר רציחה ממש. ואין זה דומה להסרת המונע דמבואר ברמ"א (יו"ד שלט, א) להתיר, דכאן הוא בגוף החולה עצמו.

הלכך בעניי לא ידעתי להסביר דעת אדמו"ר שליט"א (כוונתו לרב שלמה זלמן אויערבך),

אלא אם כן מתיר אף הריגה בידיים להקל סבל החולה, ועל זה יש לדון בנפרד. שוב שמעתי

מאדמו"ר שליט"א שצירף כסיבה להקל - שאין כל זריקה בפני עצמה מקצרת חיי החולה בהכרח, אלא מבין רבות מתקצרים חייו".

לפי דברי הרב נבנצאל שליט"א, שפורסמו בשנת תש"מ כנ"ל, יש לאסור את מתן המורפין כאשר המינון עלול לקצר את חיי החולה - אולם הוא הדגיש כי האיסור חל דווקא על מנה שבכוחה לגרום למוות בפני עצמה, ולא על מנה שהשפעתה המזיקה היא מצטברת בלבד ועקיפה. [יש לציין כי בתשובה בעל-פה מאוחרת יותר, לאחר שנחשף למידע עדכני, שינה הרב נבנצאל את עמדתו בסוגיה זו, ראו בהמשך].

אולם, על בסיס המאמרים הרפואיים-מדעיים שהבאנו עד כה, נראה שהנחת היסוד שעליה התבססו חלק מהפוסקים שונה מהידוע כיום על פי המחקר. כך, פוסקים שדנו ספציפית בסוגיית הנשימה וטענו כי מורפין גורם לדיכוי נשימתי ומקצר חיים - לגביהם, הממצאים המחקריים שהצגנו מחייבים בחינה מחודשת של המציאות היות שבמחלות ובמצבים שתוארו, מורפין הוכח כמשפר את סטורצית החמצן בדם ואף כמשפר את סיכויי ההישרדות, מעבר להקלת הסבל. לפיכך, ייתכן שאף מי שאסר בעבר על בסיס הנחה זו היה שוקל להתיר לאור המידע החדש. מעבר לכך, השיקולים שהוזכרו בפוסקים כגון עיקרון הכוונה או שאלת ה"גרימת מוות" לא יהיו רלוונטיים למתן מורפין לדיספניאה במינונים המומלצים.

האם יש חובה הלכתית למתן מורפין במצבי קוצר נשימה?

לאחר שהתברר כי עבור דיספניאה מתן מורפין אינו מקצר חיים, עלינו לבחון שאלה הלכתית אחרת - האם יש חובה הלכתית להקלת הסבל במקרים כאלה? בדבריו שציטטנו לעיל, הרב שלמה זלמן אויערבאך נעזר בדברי רש"י כדי להוכיח שיש חובה של 'ואהבת לרעך כמוך' בהקלת יסורים של אדם אחר.

במהלך כתיבת המאמר פנינו (עם אח נוסף) לרב נבנצאל כדי לשאול אותו על מתן מורפין לקוצר נשימה. הרב נבנצאל פסק לנו כי מכיוון שמורפין במצבים כאלה, במינונים מותאמים, אינו מסכן את חיי המטופל, אין מניעה לתת אותו, ואף יש חובה להשתמש בו כתרופה לקוצר הנשימה אשר מרגישים חולים אלו. כמו כן פנינו לרב אשר וייס, וגם הוא אמר כי יש מצווה לתת מורפין למטופלים אשר סובלים, ולא לחשוש לסיכון קיצור החיים אשר יכול להיגרם, שכן מדובר בתרופה חשובה.

דברי הרבנים מבהירים שמעבר למצוה הכללית של "ואהבת לרעך כמוך" שמטילה על כל יהודי את החובה לפעול להקלת סבלו של חברו, טיפול להקלת כאב נחשב חלק בלתי נפרד

מהטיפול הרפואי, והוא בכלל המצוה המוטלת על הרופא לטפל בחולה ולרפאותו, גם אם אין בידו להושיע את החולה בקשר למחלתו היסודית אלא רק להקל על סבלו. יחס זה לטיפול בכאב מתחזק לאור דברי הגמרא (כתובות לג ע"א-ע"ב), המעלה את הסברה שסבל וייסורים קשים אף ממיתה. אם כך, כשם שפשוט שהצלה ממיתה היא ההיבט העליון של רפואה, כך עלינו גם להתייחס ברצינות להצלה מן הייסורים, ולראות בה חלק מהותי מחובת הטיפול הרפואי.

צער בעלי חיים בבני אדם

מצווה נוספת העשויה לחייב מתן טיפול להקלת סבל, ככל שאין בו חשש לקיצור חיי המטופל, היא מצוות צער בעלי חיים, וזאת על בסיס דברי הרשב"א, שכתב בתשובה (ח"א סימן רנב) שאיסור צער בעלי חיים שייך אפילו בבני אדם. כלומר, לא רק בבהמות נאמרה החובה לסייע בפריקת משא, אלא אפילו באדם הנושא משא - חובה על האדם לסייע בפריקתו ובכך להקל מעליו. כך נפסק אף בברכי יוסף (יו"ד סימן שעב, סעיף ב).

אמנם הרדב"ז (סימן תשכח) חלק וכתב שאין חובת פריקה וטעינה בנוגע לאדם, וביאר: "ובאדם לא אמרו צער האדם, לפי שהוא בעל שכל ולא היה לו לטעון עצמו יתר מן הראוי לו". עם זאת, מודה הרדב"ז שוודאי חובה עלינו להציל את בני האדם מן הצער מדין "ואהבת לרעך כמוך", אלא שאין זה בכלל חובת פריקה וטעינה.

אך לכאורה, טענת הרדב"ז אינה רלוונטית בענייננו. קוצר נשימה הנובע ממחלה אינו בידי האדם ואינו תוצאה של בחירתו, ולכן לא ניתן לומר עליו "לא היה לו לטעון עצמו יתר מן הראוי". ממילא, אף לשיטת הרדב"ז, במקרה של סבל הנובע ממחלה שאינה תלויה בבחירת האדם, חלה בהחלט חובה להקל על האדם הסובל.

סיכום

במאמר זה סקרנו את השפעת הטיפול באופיאטים על דיספניאה - קוצר נשימה המתרחש בתדירות גבוהה בקרב חולי אי-ספיקת לב, סרטן מתקדם ומחלת ריאות כרונית, ומופיע רבות גם אצל מטופלים בחדר המיון כאשר מצבם מחמיר לקראת סוף חייהם. הראנו שהספרות הרפואית ממליצה כיום על מתן אופיאטים להקלה על קוצר הנשימה, ושמתי מורפין במינון מתאים הוכח כמשפר את ריכוז החמצן בגוף ומקל על הסבל - וזאת ללא סכנה לקיצור חיי המטופל.

מסקנתנו היא שנראה כי לאור כל המידע הרפואי וההלכתי המפורט, מומלץ לתת מורפין כטיפול לקוצר נשימה במטופלים עם התוויה מתאימה לכך - ובכלל זה חולי סרטן, אי-ספיקת לב ומחלת ריאה כרונית - גם לקראת סוף חייהם, הן מבחינה רפואית והן מבחינה הלכתית.

ייתכן שיש החוששים מ"מדרון חלקלק", כיוון שבטיחות הטיפול במורפין תלויה במתן המינון הנכון כפי שנבדק במחקרים שהובאו. עם זאת, אם נחשוש לכך, הרי ש"לא שבקת חיי לכל בריה" - שכן בעיית הסיכון שבמינון יתר קיימת בתרופות רבות, ואין אנו נמנעים מטיפולים תרופתיים מחמת חשש זה בשאר תחומי הרפואה. נראה שהנכון הוא להנחות את צוותי הרפואה לטפל במטופלים בצורה מיטבית, כולל טיפול במורפין למטופל עם קוצר נשימה שיש לו התוויה לטיפול זה, תוך הקפדה על המינון הנכון והמותאם.

יחד עם זאת, ראוי לציין כי קיימים מצבים הדורשים זהירות יתירה אף בטיפול המוצדק, ובהם יש להיוועץ ברופא מומחה ולנהוג בשיקול דעת מיוחד:

- **אי-ספיקת כליות** - מורפין עלול להצטבר ברקמות; במצב זה מומלץ לשקול מעבר לאופיואיד חלופי כגון אוקסיקודון או הידרומורפון.
 - **דום נשימה בשינה (Sleep Apnea)** - רגישות מוגברת לדיכוי נשימתי, המחייבת זהירות במינון.
 - **חולים שאינם מורגלים באופיואידים (opioid naïve)** - יש להתחיל במינון נמוך במיוחד ולהעלותו בהדרגה תחת פיקוח.
- ההחלטה הסופית מסורה לרופא המטפל, בהתאם למצבו הספציפי של כל מטופל.

בביליוגרפיה

1. Parshall MB, Schwartzstein RM, Adams L, Banzett RB, Manning HL, Bourbeau J, et al. An official American Thoracic Society statement: update on the mechanisms, assessment, and management of dyspnea. Am J Respir Crit Care Med. 2012 Feb 15;185(4):435-52.
2. Baker Rogers J, Modi P, Minter JF. Dyspnea in Palliative Care. 2024.

3. Dudgeon D. Assessment and management of dyspnea in palliative care. ed UpToDate Waltham, MA: UpToDate Inc <http://www.uptodate.com> Accessed May 24, 2022.
4. Stanzani LZL, Marques M, Martins M, Vieira W, Amorim F, Carvalho R. Morphine use in the treatment of dyspnea in terminally ill patients. In: Clinical problems. European Respiratory Society; 2021. p. PA3135.
5. Tanaka K, Shima Y, Kakinuma R, Kubota K, Ohe Y, Hojo F, et al. Effect of nebulized morphine in cancer patients with dyspnea: a pilot study. *Jpn J Clin Oncol*. 1999 Dec;29(12):600-3.
6. Dudgeon DJ, Kristjanson L, Sloan JA, Lertzman M, Clement K. Dyspnea in Cancer Patients. *J Pain Symptom Manage*. 2001 Feb;21(2):95-102.
7. Taniguchi Y, Matsuda Y, Mori M, Ito M, Ikari T, Tokoro A, et al. Effectiveness and safety of opioids for dyspnea in patients with lung cancer: secondary analysis of multicenter prospective observational study. *Transl Lung Cancer Res*. 2022 Dec;11(12):2395-402.
8. Azoulay D, Jacobs JM, Cialic R, Mor EE, Stessman J. Opioids, survival, and advanced cancer in the hospice setting. *J Am Med Dir Assoc*. 2011 Feb;12(2):129-34.
9. Hu WY, Chiu TY, Cheng SY, Chen CY. Morphine for dyspnea control in terminal cancer patients: is it appropriate in Taiwan? *J Pain Symptom Manage*. 2004 Oct;28(4):356-63.
10. Jessup M, Brozena S. Heart failure. *N Engl J Med*. 2003 May 15;348(20):2007-18.
11. Kawaguchi J, Hamatani Y, Hirayama A, Nishimura K, Nakai E, Nakamura E, et al. Experience of morphine therapy for refractory dyspnea as palliative care in advanced heart failure patients. *J Cardiol*. 2020 Jun;75(6):682-8.

12. Verberkt CA, van den Beuken-van Everdingen MHJ, Schols JMGA, Hameleers N, Wouters EFM, Janssen DJA. Effect of Sustained-Release Morphine for Refractory Breathlessness in Chronic Obstructive Pulmonary Disease on Health Status: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Intern Med.* 2020 Oct 1;180(10):1306-14.

13. Smith AK, McCarthy E, Weber E, Cenzer IS, Boscardin J, Fisher J, et al. Half Of Older Americans Seen In Emergency Department In Last Month Of Life; Most Admitted To Hospital, And Many Die There. *Health Aff.* 2012 Jun;31(6):1277-85.

14. Shreves A, Pour TR. Emergency department management of dyspnea in the dying patient. *Emerg Med Pract.* 2018 Jul;20(7):1-20.

15. Fry M, Holdgate A. Nurse-initiated intravenous morphine in the emergency department: efficacy, rate of adverse events and impact on time to analgesia. *Emerg Med (Fremantle).* 2002 Sep;14(3):249-54.

16. Smallwood NE, Pascoe A, Wijsenbeek M, Russell AM, Holland AE, Romero L, Ekström M. Opioids for the palliation of symptoms in people with serious respiratory illness: a systematic review and meta-analysis. *Eur Respir Rev.* 2024 Oct 9;33(174):230265. doi: 10.1183/16000617.0265-2023.

17. Holland AE, Spathis A, Marsaa K, Bausewein C, Ahmadi Z, Burge AT, Pascoe A, Gadowski AM, Collis P, Jelen T, Reilly CC, Reinke LF, Romero L, Russell AM, Saggu R, Solheim J, Vagheggini G, Vandendungen C, Wijsenbeek M, Tonia T, Smallwood N, Ekström M. European Respiratory Society Clinical Practice Guideline on symptom management for adults with serious respiratory illness. *Eur Respir J.* 2024;63(6):2400335. doi: 10.1183/13993003.00335-2024.

18. Pascoe A, Smallwood NE. The changing role of opioids for symptom management in people with advanced lung disease. *Expert Rev Respir Med.* 2025;19(2):83-85. doi: 10.1080/17476348.2025.2459304.

